MON CARNET NUMÉRIQUE — CAHIER DES CHARGES

Version 9 — réécriture alignée sur le code courant · État vérifié au 08 octobre 2026

Nom technique : E-Carnet

Document de référence produit, fonctionnel et technique. Cette version remplace l'ancien CDC V8. Elle décrit le comportement actuellement implémenté ou explicitement prévu par le dépôt ; elle ne transforme pas les points encore non validés en engagements de production.

0. Statut du document

Élément	État
Version	V9 — actualisée le 08/10/2026
Base de référence	Code courant du dépôt + docs/ETAT-REEL-V1.md + roadmap + décisions A1–A16 + rapports de recette
État produit	V1 en construction
Données réelles de santé	INTERDITES à ce stade
Verdict	NO-GO production
Tests API disponibles	77 réussis / 0 échec / 0 ignoré sur PostgreSQL 16 local, preuve du 08/10
Restauration locale	Smoke PostgreSQL local réussi le 08/10 ; ce n'est pas un RTO de production
Recette staging	Non signée
Validation médicale	À obtenir
Validation juridique / protection des données	À obtenir
Hébergement ivoirien pour données réelles	À définir et valider

0.1 Règle de lecture

- FAIT / PRÉSENT : le comportement est retrouvé dans le code courant.
- À RECETTER : le code existe mais doit encore être éprouvé sur staging, appareils réels ou fournisseur réel.
- À VALIDER : décision médicale, juridique, sécurité, exploitation ou produit encore ouverte.
- HORS V1 : explicitement exclu du périmètre courant.
- NO-GO : absence de preuve suffisante pour autoriser des données de santé réelles.

1. Vision et proposition de valeur

Mon Carnet Numérique est une application web/PWA mobile-first centrée sur le patient. Elle fournit un carnet personnel et organise un accès clinique temporaire et contrôlé lorsque le patient autorise un professionnel dans le contexte d'un établissement.

La V1 n'est pas un dossier médical partagé national, ni un système hospitalier complet, ni une plateforme d'IA clinique. Son cœur est : identité, carnet patient, pré-consultation, consultation, rattachement professionnel/établissement, autorisation temporaire, provenance, audit et isolation inter-établissements.

1.1 Principes directeurs

- Le patient conserve la maîtrise de son carnet et décide de l'accès clinique.
- Un professionnel ne lit aucune donnée clinique sans contexte professionnel actif, établissement actif, rattachement actif et autorisation serveur du patient.
- Une donnée déclarée par le patient ne doit pas être présentée comme une donnée médicalement vérifiée.
- Une consultation ou une correction importante doit conserver sa provenance et son historique ; pas d'écrasement silencieux.

- Un établissement ne donne pas automatiquement accès aux données d'un autre établissement.
- Les contrôles d'accès sont exécutés côté serveur ; les gardes UI ne sont qu'une aide d'ergonomie.
- Les données de santé ne sont pas utilisées en développement/staging/pilote tant que les gates Go/No-Go ne sont pas signées.

2. Périmètre réellement livré / en construction

Bloc	État actuel
Application web/PWA	Présente
Patient	Présent
Professionnel	Présent
Établissement	Présent, flow largement implémenté
Staff plateforme	Présent pour opérations d'établissement
Sessions serveur	Présentes
CSRF/CORS	Configurés
Argon2id	Configuré
OAuth Google/Facebook/Apple	Callbacks + liaison/déliaison présents ; recette fournisseur à faire
MFA TOTP professionnel	Présent côté modèle/flux ; recette complète à faire
Pré-consultation	Présente : brouillon + clôture + révision
AccessGrant	Présent : demande, consentement/refus, expiration, prolongation, révocation
QR	Présent : jeton opaque hashé, usage unique, 5 min
Consultation	Présente
Attestation SVG	Présente, sanitation stricte + hash SHA-256
Audit	Présent
PWA	Présente
Stockage documentaire	Prévu/partiellement présent selon le parcours ; politique de stockage/rétention à valider
Production santé réelle	Non autorisée

3. Utilisateurs, rôles et contextes

Contexte	Rôle	Responsabilités V1
Patient	patient	Gérer son identité/carnet, déclarations, pré-consultation, historique et autorisations.
Professionnel	professional	Profil professionnel, MFA, rattachements, établissement actif, demandes/consultations selon autorisation.
Établissement	establishment	Gérer la structure, son administrateur, les professionnels rattachés et leurs demandes.
Staff plateforme	staff	Activer/administrer les établissements et opérations de plateforme prévues ; ne constitue pas un accès clinique patient.
Infirmier	—	Aucun compte, aucun rôle et aucun espace autonome en V1.

Une identité utilisateur centrale peut porter plusieurs contextes sans créer plusieurs comptes. Le code courant modélise les contextes Patient, Professionnel et Établissement.

4. Identité et authentification

4.1 Compte unique

- Un utilisateur interne peut associer plusieurs méthodes d'authentification sans créer de doublon d'identité.
- Fournisseurs OAuth présents dans le code : Google, Facebook et Apple.
- Aucune fusion ne doit être déduite de la seule égalité d'e-mail OAuth.
- Le mot de passe est géré par Django lorsque le parcours mot de passe est utilisé ; Argon2id est configuré en premier hasher.
- Les sessions sont côté serveur ; pas de JWT stocké dans localStorage.

4.2 MFA

- Le modèle MfaDevice et le parcours TOTP sont présents.
- Le MFA est une exigence des profils professionnels ; l'accès clinique dépend de la présence du contexte professionnel et des contrôles serveur associés.
- Le parcours exact de récupération/réinitialisation MFA doit encore être recetté et documenté pour la production.

4.3 Récupération

La récupération avancée des comptes sociaux et les procédures exceptionnelles restent à formaliser. Toute récupération de compte ou de MFA doit produire une preuve d'identité et une trace d'audit avant production.

5. Onboarding

Le frontend actuel organise l'onboarding autour de l'identité puis du contexte métier.

- Identité : nom/prénom et avatar par URL éditable.
- Choix du contexte : Patient ou Professionnel.
- Formulaire métier conditionnel au contexte.
- Le parcours professionnel conduit au profil professionnel, au MFA et au rattachement établissement.
- Les justificatifs professionnels personnels ne sont pas collectés par le flow courant ; la vérification institutionnelle doit rester explicitement attribuée à l'acteur qui la réalise.

6. Parcours patient

6.1 Carnet

- Profil patient.
- Déclarations cliniques : antécédent, allergie, traitement.
- Pré-consultations.
- Consultations disponibles après autorisation et selon le contexte.
- Historique des accès et autorisations.
- Paramètres du compte.

6.2 Déclarations

Type	Statuts code
Antécédent	declared / cancelled
Allergie	declared / cancelled
Traitement	declared / cancelled

La provenance « déclaré par le patient » doit rester visible. Une annulation ne doit pas supprimer silencieusement l'historique.

6.3 Pré-consultation

Le modèle CareEncounter comporte notamment établissement, libellé d'établissement, motif, observations, aide éventuelle à la saisie, statut et date de clôture.

État	Usage
draft	Brouillon
closed	Clôturée

- La pré-consultation appartient au compte patient.
- Elle peut être réalisée avec l'aide d'une personne non authentifiée ; le champ recorded_with_help ne crée aucun compte ni droit.
- La clôture est historisée via PreConsultationRevision.
- Une pré-consultation n'est pas un diagnostic.
- Les champs médicaux définitifs et leurs unités doivent être validés médicalement avant production.

7. Professionnel

- Profil professionnel : titre, spécialité, identifiant professionnel éventuel et statut de vérification.
- Le code actuel prévoit les statuts pending, verified, rejected.
- Le statut verified n'est pas, à lui seul, le gate d'accès clinique : le contrôle serveur vérifie surtout contexte, établissement actif, rattachement et AccessGrant.
- MFA TOTP.
- Liste et sélection de l'établissement actif.
- Demandes d'accès/consultations dans le périmètre autorisé.

8. Établissement et rattachement

8.1 Établissement

Statut	Sens
pending	En attente
active	Actif
rejected	Refusé

La création/activation actuelle passe par des routes staff protégées. Le flow public historique de création d'établissement n'est plus la référence.

8.2 Administrateur

Le modèle EstablishmentAdministrator est nominatif et historisé.

Statut	Sens
active	Actif
revoked	Révoqué
ended	Terminé

Le code prévoit un administrateur actif par structure en V1. Les invitations d'administrateur sont à usage unique et valables 48 h ; le transport est configurable via SMTP Django.

8.3 Médecin / professionnel

Le code courant utilise un code de rattachement hashé, à usage unique et valable 48 h. Sa saisie crée une demande pending ; l'administrateur de l'établissement accepte ou refuse.

Statut membership	Sens
pending	En attente
active	Actif
refused	Refusé
suspended	Suspendu

terminated	Terminé

Le rattachement conserve notamment la version des conditions acceptées et les informations d'acceptation lorsque celles-ci sont utilisées.

8.4 Départ

- Les droits futurs dans l'établissement sont bloqués.
- Le rattachement passe par un état historique plutôt que par une suppression silencieuse.
- Les consultations historiques restent dans leur contexte.
- Les traces d'audit sont conservées selon la politique de rétention à valider.

9. Accès clinique — AccessGrant

AccessGrant est l'objet serveur central de l'autorisation temporaire. Il lie le patient, le professionnel et l'établissement lorsque ces références sont disponibles et porte le périmètre demandé, les dates et l'état.

Statut	Transition
pending	Demande en attente
active	Autorisation active
refused	Refus patient
expired	Expiration serveur
revoked	Révocation

9.1 Règles V1

- Le patient voit qui demande l'accès, dans quel établissement, pour quel périmètre et pour quelle durée.
- L'autorisation est contrôlée côté serveur.
- Durée initiale : 2 heures.
- Deux prolongations d'une heure sont prévues, soit 4 heures maximum.
- L'expiration doit être appliquée par le serveur, pas seulement par le frontend.
- La révocation met fin à l'accès.
- Un professionnel ne peut pas utiliser une autorisation d'un établissement pour consulter une prise en charge d'un autre établissement.

10. QR d'accès

- Le QR transporte une demande d'accès, pas une donnée médicale.
- Le jeton est opaque et hashé en base.
- Usage unique.
- Validité produit : 5 minutes.
- Un jeton expiré ou déjà consommé est refusé.
- Le code courant possède génération côté patient et lecture caméra/saisie côté professionnel.
- Point restant à corriger/recetter : le formulaire professionnel demande encore séparément l'UUID patient ; le parcours cible doit supprimer cette friction si le jeton permet de résoudre le patient de façon sûre.

11. Scopes V1

Scope	État
preconsultation	Inclus par défaut
declarations	Inclus par défaut
consultations	Sélectionnable explicitement
documents	Hors V1

Ces scopes sont ceux documentés comme décision A9 et appliqués par le code. Le patient doit comprendre le périmètre avant d'autoriser.

12. Consultation

- Le professionnel retrouve la pré-consultation autorisée.
- La consultation est persistée dans le contexte du patient et de l'établissement.
- Le modèle actuel comprend une consultation et un système de révisions.
- Les corrections ne doivent pas devenir des écrasements silencieux ; les mécanismes de révision doivent rester audités.
- Une ordonnance structurée n'est pas dans le périmètre V1.
- Le contenu médical définitif, les champs obligatoires, unités et règles de correction doivent être validés par le référent médical.

13. Attestation médicale / SVG

- Le code accepte une attestation SVG dans le workflow de consultation.
- Le SVG est nettoyé par une allowlist stricte.
- Les charges script/CSS/URL externe/DTD et autres contenus non autorisés sont bloqués.
- Le contenu est hashé en SHA-256 et horodaté.
- Cette attestation ne doit jamais être présentée comme une signature électronique qualifiée sans base juridique et technique correspondante.

14. Documents

Le périmètre documentaire est volontairement limité en V1. Le document source du produit prévoit PDF/JPEG/PNG comme formats de travail et un plafond de l'ordre de 10 Mo, mais la politique finale de stockage, chiffrement, antivirus, rétention, export et suppression reste à recetter/valider.

- Aucun document médical ne doit être placé dans Redis ou dans le HTML public.
- Le stockage final doit être privé et utiliser des URLs signées courtes lorsque cette fonction est activée.
- Les règles de conservation des justificatifs d'établissement et des documents cliniques doivent être définies séparément.

15. Audit et traçabilité

AuditEvent constitue le mécanisme de traçabilité des actions sensibles.

- Chaque événement doit permettre de déterminer qui a agi, quoi, quand, pour quel patient, dans quel établissement, avec quel rôle et dans quel contexte d'autorisation.
- Le contenu médical détaillé ne doit pas être recopié dans les logs techniques.
- L'audit doit rester append-only ou équivalent historiquement immuable.
- Les contrôles DB et l'export hors base doivent être éprouvés en staging avant de parler de garantie d'immutabilité.

16. Isolation inter-établissements

Principe non négociable : l'établissement actif est une donnée métier explicite. Une consultation réalisée dans l'établissement A ne devient pas visible dans B parce que le même professionnel possède un rattachement dans B.

- Chaque action clinique vérifie utilisateur, rôle, patient, établissement actif, rattachement, AccessGrant, scope, statut et expiration.
- Le frontend ne constitue jamais la barrière de sécurité.
- Les tests de concurrence et d'isolation A/B doivent être exécutés sur staging.

17. Architecture technique actuelle

Couche	Référence actuelle

Frontend	Next.js 16 / React 19, application web/PWA
API	Django 5.2 + Django REST Framework
Base cible	PostgreSQL
Développement/local	PostgreSQL 16 démontré dans la suite récente ; SQLite existe encore comme défaut local historique
Frontend hosting envisagé/actuel	Vercel
API hosting envisagé/actuel	Render
Sessions	Sessions serveur, cookies HttpOnly/Secure selon environnement
Sécurité web	CSRF + CORS
Hash mots de passe	Argon2id prioritaire
Stockage fichiers	Privé à URLs signées pour les flux concernés
OAuth	Google / Facebook / Apple
MFA	TOTP pour contexte professionnel

Le choix exact de la base managée et la localisation de production doivent être décidés séparément. Pour les données réelles, la résidence et les contrats d'hébergement doivent être validés juridiquement et opérationnellement.

18. Frontend, routes et espaces

Espace	**Routes/écrans actuellement présents**
Public	/, /a-propos, /faq, /securite, /conditions-rattachement, /connexion, /inscription, /v1
Onboarding	/onboarding, /onboarding/identite, /onboarding/patient
Patient	/patient, /patient/carnet, /patient/consultations, /patient/acces, /patient/parametres
Professionnel	/professionnel, /professionnel/onboarding, /professionnel/patients, /professionnel/acces, /professionnel/consultations, /professionnel/etablissements, /professionnel/parametres
Établissement	/etablissement, /activation, /demandes, /gestion, /medecins, /parametres, /aide
Staff	/staff/etablissements, /staff/medecins

Le nombre de routes doit être généré/revérifié par le build courant plutôt que repris depuis les anciens rapports.

19. UX / UI et direction visuelle

- Mobile-first, Android courant, réseau parfois instable.
- Formulaires progressifs et textes simples.
- Chaque vue gère chargement, erreur, vide et succès.
- Provenance toujours exprimée par libellé + signal visuel ; jamais par couleur seule.
- Direction de marque à formaliser dans le brief DA : palette officielle, typographie, logo, icônes, motion.
- Le dépôt contient actuellement plusieurs thèmes/palettes et plusieurs familles typographiques ; la DA finale doit figer un seul système de production.

Le présent CDC ne fige pas arbitrairement la DA : le brief DA séparé constitue la référence graphique après validation.

20. Pages publiques et communication

- Les pages publiques sont indexables selon les règles du projet ; les espaces privés ne doivent pas exposer de données sensibles au HTML public.
- Les pages sécurité, FAQ, à-propos et conditions de rattachement doivent rester alignées avec le texte juridique final.
- Les mentions « sécurisé », « vérifié », « conforme », « certifié » ou équivalentes doivent être employées uniquement après validation des preuves correspondantes.
- La page /v1 est une page de présentation interne/non indexable dans le code actuel et ne doit pas être utilisée comme preuve de readiness production.

21. Sécurité applicative

- Sessions serveur.
- Cookies HttpOnly et Secure hors debug.
- CSRF/CORS configurés.
- Argon2id.
- Rate limiting/throttling à vérifier sur tous les endpoints sensibles.
- Sanitation SVG par allowlist.
- QR opaque hashé et à usage unique.
- Audit des actions sensibles.
- Isolation serveur par établissement.
- Aucune donnée médicale réelle en environnement non approuvé.

21.1 Points de sécurité restant à prouver

- Permissions DB et protection TRUNCATE sur staging.
- Restauration réelle de l'instance managée.
- RPO/RTO mesurés.
- OAuth réel et sécurité des callbacks.
- SMTP, SPF/DKIM/DMARC et délivrabilité.
- Rate limits et sessions sur domaines réels.
- Audit des dépendances actuel.
- Tests Android/iOS/4G et accessibilité WCAG 2.2 AA.

22. Données et modèle fonctionnel

Entité code	Rôle
AccountProfile	Profil central du compte
AccountContext	Contexte Patient / Professionnel / Établissement
AuthIdentity	Liaison OAuth Google/Facebook/Apple
ThemePreference	Préférence de thème
PatientProfile	Profil patient
ClinicalDeclaration	Antécédent / allergie / traitement déclaré
CareEncounter	Pré-consultation
PreConsultationRevision	Historisation pré-consultation
AccessGrant	Autorisation temporaire
PatientAccessQrToken	Jeton QR d'accès
Consultation	Consultation professionnelle
ConsultationRevision	Révisions de consultation
Establishment	Structure de santé
EstablishmentAdministrator	Administrateur nominatif historisé
EstablishmentAdminInvitation	Invitation administrateur
EstablishmentJoinCode	Code de rattachement professionnel
EstablishmentMembership	Rattachement professionnel
ProfessionalProfile	Profil professionnel
MfaDevice	MFA TOTP
ProfessionalSpecialty	Spécialité
AuditEvent	Journal d'audit

23. Statuts métier de référence

Objet	Valeurs du code
CareEncounter	draft, closed
AccessGrant	pending, active, refused, expired, revoked
Establishment	pending, active, rejected
EstablishmentAdministrator	active, revoked, ended

EstablishmentMembership	pending, active, refused, suspended, terminated
ProfessionalProfile	pending, verified, rejected
ClinicalDeclaration	declared, cancelled
ClinicalDeclaration.kind	antecedent, allergy, treatment
AccountContext.role	patient, professional, establishment
AuthIdentity.provider	google, facebook, apple

24. V1 — périmètre

24.1 Inclus

- Compte unique et onboarding.
- Patient : carnet, déclarations, pré-consultation, historique.
- Professionnel : profil, MFA, établissement actif, rattachement.
- Établissement : administration nominative, invitations, demandes de rattachement.
- AccessGrant : demande, consentement/refus, scopes, expiration, prolongations, révocation.
- QR d'accès opaque, 5 minutes, usage unique.
- Consultation et révisions.
- Audit.
- PWA.
- Pages publiques de présentation, sécurité et aide.

24.2 Hors V1

- Compte infirmier autonome.
- Partage/transfert de dossier inter-établissements.
- Ordonnance structurée.
- Téléconsultation.
- IA clinique.
- Paiement patient.
- Application native.
- Intégrations laboratoire/pharmacie.
- Administration plateforme avancée.
- Hors-ligne complet avec synchronisation.
- Récupération avancée de comptes sociaux.

25. V2 / V3

Version	Orientation
V2	Consolidation après pilote : administration avancée, organisation avancée, hors-ligne/synchronisation, récupération avancée, ordonnance structurée selon validation.
V3	Inter-établissements : demande/récupération/transfert contrôlé de dossiers, provenance inter-structure, contrats et règles de conservation associées.

Aucune fonction V2/V3 ne doit être introduite dans la V1 au motif qu'elle figure dans un ancien CDC.

26. Modèle économique

Orientation actuelle : B2B établissement. Le patient n'a pas d'abonnement individuel prévu. Le financement public n'est pas considéré comme acquis.

L'unité de facturation et le tarif restent commerciaux et ne constituent pas une exigence fonctionnelle de la V1.

- Le CDC produit ne doit pas transformer une hypothèse commerciale en engagement.
- Les éventuels onboarding, formation, support premium, intégrations ou stockage supplémentaire sont des offres futures à cadrer.

27. Protection des données et conformité

Le produit manipule potentiellement des données de santé. Le CDC ne constitue ni un avis juridique, ni une certification de conformité, ni un audit de sécurité.

- Responsable(s) de traitement et sous-traitants : à formaliser.
- Finalités, bases juridiques et consentements : à formaliser.
- Durées de conservation : à formaliser.
- Exercice des droits : à formaliser.
- Incidents et notifications : à formaliser.
- Localisation et transferts internationaux : à valider.
- Contrats hébergeurs et prestataires : à valider.
- Politique de stockage documentaire : à valider.
- Règles spécifiques aux données de santé en Côte d'Ivoire : à faire confirmer par le juriste compétent.

28. État réel au 08/10/2026

Preuve	**Résultat / limite**
Tests Django PostgreSQL 16	77 OK, 0 échec, 0 ignoré — preuve locale du 08/10
Smoke restauration PostgreSQL local	OK ; ne constitue pas un RTO opérationnel
Build/lint	Résultats historiques du 05/10 ; à rejouer avant release
OAuth	Code présent ; credentials et recette fournisseurs réels à faire
SMTP	Transport configurable présent ; délivrabilité staging à faire
QR	Backend + UI présents ; parcours encore à fluidifier
SVG	Sanitation stricte + tests adversariaux présents
Staging managé	Non démontré comme recette finale
Mobile réel	À recetter
Validation médicale	Non signée
Validation juridique	Non signée
Données réelles	Interdites

29. Go / No-Go production

Le statut actuel est NO-GO. La V1 ne peut passer GO que lorsque les preuves suivantes sont réunies :

1. 1. Tests sur la base managée de staging.
2. 2. Permissions DB, append-only et isolation A/B vérifiées.
3. 3. Sauvegarde/restauration managée testée et RPO/RTO approuvés.
4. 4. SMTP réel configuré et délivrable.
5. 5. OAuth réel testé.
6. 6. QR complet testé sur mobile.
7. 7. Accessibilité et responsive recettés.
8. 8. Dépendances auditées et vulnérabilités traitées ou acceptées formellement.
9. 9. Validation médicale des champs et workflows.
10. 10. Validation juridique / protection des données.
11. 11. Hébergement et localisation des données approuvés.
12. 12. Procédure d'incident approuvée.
13. 13. CA-01 à CA-24 signés sur staging.
14. 14. Décision Go/No-Go formelle.

30. Critères d'acceptation fonctionnels — version de référence

La matrice de recette détaillée reste le support d'exécution. Les critères ci-dessous constituent le périmètre à couvrir et non une affirmation qu'ils sont déjà tous validés.

- CA-01 : création/connexion d'un compte.
- CA-02 : onboarding Patient.
- CA-03 : onboarding Professionnel.
- CA-04 : activation et contrôle MFA professionnel.
- CA-05 : création/activation d'un établissement via le flow staff.
- CA-06 : invitation administrateur et expiration 48 h.
- CA-07 : code de rattachement professionnel, expiration 48 h et usage unique.
- CA-08 : acceptation/refus d'un rattachement.
- CA-09 : sélection de l'établissement actif.
- CA-10 : création d'une pré-consultation.
- CA-11 : clôture et historisation.
- CA-12 : demande AccessGrant.
- CA-13 : consentement/refus patient.
- CA-14 : scopes appliqués.
- CA-15 : expiration 2 h.
- CA-16 : prolongations limitées.
- CA-17 : révocation.
- CA-18 : QR opaque, 5 min, usage unique.
- CA-19 : isolation inter-établissements.
- CA-20 : consultation et révisions.
- CA-21 : audit des actions sensibles.
- CA-22 : sauvegarde/restauration.
- CA-23 : responsive/accessibilité/mobile.
- CA-24 : Go/No-Go avec preuves et validations externes.

31. Roadmap de livraison

Phase	Objectif	Sortie attendue
A — Stabilisation	Corriger les derniers écarts fonctionnels et QR	Code + tests
B — Staging	PostgreSQL managé, SMTP, OAuth, domaines, stockage privé	Environnement réaliste
C — Sécurité	Permissions DB, audit, dépendances, rate limits, incident	Dossier sécurité
D — Terrain technique	Android/4G, accessibilité, restauration, concurrence	Rapport de recette
E — Validation métier	Médecin référent + juriste + protection des données	Avis/validation
F — Go/No-Go	CA-01 à CA-24	Décision formelle
G — Pilote	Uniquement après GO et selon les règles de données approuvées	Pilote contrôlé

32. Livrables par rôle

Rôle	Livrable
Produit/fondateur	Décisions verrouillées, priorités, Go/No-Go
Développement	Code, migrations, tests, ADR, documentation technique
Médecin référent	Champs et logique médicale, terminologie, workflow de consultation
Juriste	Conditions, confidentialité, consentements, conservation,

	responsabilités, incidents
Sécurité/DevOps	Staging, sauvegardes, RPO/RTO, permissions, secrets, monitoring
Designer/DA	Identité, UI system, logo, composants, motion, templates
QA	Recette fonctionnelle, mobile, accessibilité, preuves horodatées

33. Sources de vérité après cette réécriture

- Code courant du dépôt : vérité d'implémentation.
- docs/ETAT-REEL-V1.md : état réel et preuves au 08/10/2026.
- docs/ROADMAP-V1-V5.md : décisions produit et évolution.
- docs/RECETTE-V1.md : matrice de recette.
- docs/SECURITY.md : exigences sécurité.
- docs/FLOW-ETABLISSEMENT.md + ADR établissement : flow établissement courant.
- 01-inventaire-textes-pour-revue-juridique.md : texte juridique à soumettre au juriste.
- 02-brief-direction-artistique-infographie-motion.md : direction artistique à remettre à la DA.

Tout ancien comportement contradictoire avec le code courant doit être considéré comme obsolète jusqu'à décision explicite.

34. Principe final

MON CARNET NUMÉRIQUE

Patient → carnet personnel → demande d'accès → autorisation explicite → AccessGrant temporaire → professionnel rattaché à un établissement → consultation contextualisée → historique et audit.

La promesse produit n'est pas « tout centraliser et tout partager ». La promesse V1 est de rendre le carnet personnel plus structuré, le partage plus explicite et les accès plus traçables, tout en gardant les limites techniques, médicales et juridiques visibles.

STATUT AU 08/10/2026 : V1 EN CONSTRUCTION · NO-GO DONNÉES DE SANTÉ RÉELLES.